

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Roberto Antonio Castro Mora

DOCUMENTO

CC 17123456

FECHA NACIMIENTO

14/12/1950

EDAD

75 años, 6 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Profesional (Contador)

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

22/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001252

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + GDS-15 + Evaluación Post-ACV

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Roberto Antonio Castro Mora	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 17123456	Ocupación:	Pensionado (contador)
Fecha de nacimiento:	14/12/1950	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	75 años, 6 meses	Acompañante:	María Eugenia Mora de Castro
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo
Escolaridad:	Profesional (Contador)	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

ACV isquémico de ACM derecha hace 14 meses. Hemiparesia izquierda resuelta, persiste heminegligencia izquierda leve y déficit atencional. Evaluar capacidad para retomar actividades.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + GDS-15 + Evaluación Post-ACV

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
AM Deno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	Socioemocional - Depresión	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Traumáticos

Niega TEC.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = -0.9\sigma$ sobre 6 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- Atención moderadamente descendido ($Z = -1.8\sigma$)

Implicación

Se sugiere intervención dirigida al dominio descendido, con monitoreo de respuesta a tratamiento.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida y selectiva descendidas. Heminegligencia izquierda en pruebas visoespaciales. Mejora con anclaje.

Memoria

Memoria de trabajo descendida. Memoria episódica anterógrada con perfil subcortical (mejor reconocimiento que evocación).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Funciones ejecutivas

Flexibilidad cognitiva descendida (TMT-B muy bajo). Planificación descendida. Perfil disejecutivo.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: 169.3 - Secuelas de ACV (fase crónica)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Escala de Depres

5

Normal

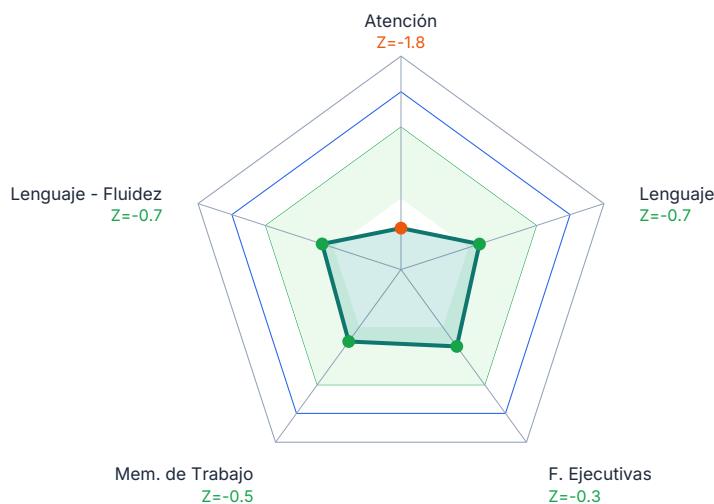
Escala de Lawton

5

Deficit Leve

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

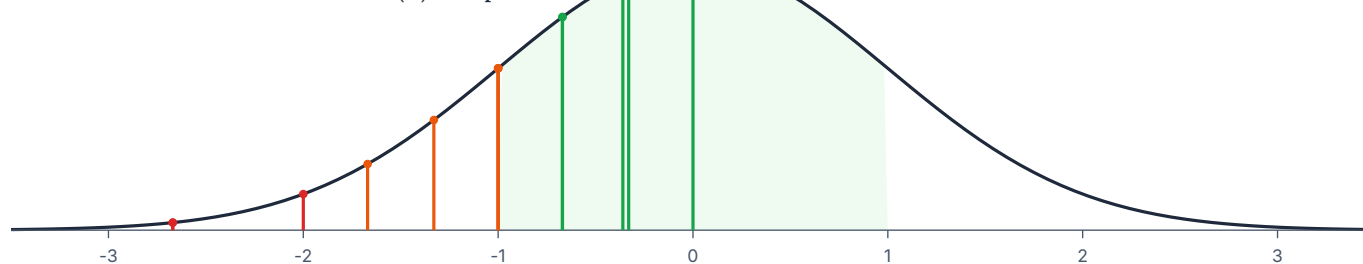


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 13 pruebas con norma disponible

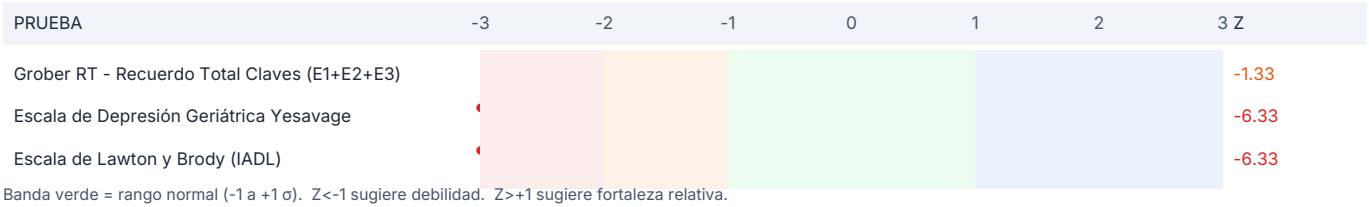


Perfil Z por prueba

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.00
TMT B							-0.33
Span Retención Dígitos Directo							+0.00
Span Retención Dígitos Inverso							-1.00
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-2.67
Test de Stroop Palabra/Color							-1.67
Fluidez Verbal Animales							-0.67
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-1.00
AM Deno							-0.36
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.67
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)							-0.67



Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z ⁻	BANDA
Atención	-1.83σ	moderado
General	-1.56σ	moderado
Lenguaje	-0.68σ	promedio
Lenguaje - Fluidez	-0.67σ	promedio
Memoria de Trabajo	-0.50σ	promedio
Funciones Ejecutivas	-0.33σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	145	7	-1.00	Promedio
TMT B	280	9	-0.33	Promedio
Span Retención Dígitos Directo	4	10	+0.00	Promedio
Span Retención Dígitos Inverso	2	7	-1.00	Promedio
Test de Stroop Palabra	32	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	25	2	-2.67	Bajo
Test de Stroop Palabra/Color	10	5	-1.67	Límitrofe
Fluidez Verbal Animales	10	8	-0.67	Promedio
Fluidez Verbal Fonémica (P)	7	7	-1.00	Promedio
AM Deno	36	36	-0.36	Promedio
Grober RL Ensayo 1 (libre)	5	2	-2.67	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	6	8	-0.67	Promedio
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	9	6	-1.33	Límitrofe
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	5	5	-6.33	Normal
Escala de Lawton y Brody (IADL)	5	5	-6.33	Deficit Leve

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: atención (moderadamente disminuido, Z=-1.8); general (moderadamente disminuido, Z=-1.6).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Color (Z=-2.67, bajo); Grober RL Ensayo 1 (libre) (Z=-2.67, bajo); Test de Stroop Palabra (Z=-2.00, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.67$)
- Test de Stroop Color — bajo ($Z=-2.67$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra/Color — límite ($Z=-1.67$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — límite ($Z=-1.33$)
- Fluidez Verbal Fonémica (P) — promedio ($Z=-1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Roberto. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En TMT B, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Test de Stroop Color, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Test de Stroop Palabra/Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

General · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En TMT B, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Fluidez Verbal Animales, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Color, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Palabra/Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Grober RL Ensayo 1 (libre), encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3), tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: I69

Impresión diagnóstica: I69.3 - Secuelas de ACV (fase crónica)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Deterioro cognitivo leve amnésico (F067) — sospecha de EA prodrómica · Adulto Mayor (50+ años)

- Valoración por neurología para caracterización etiológica (biomarcadores si aplica).
- Programa de estimulación cognitiva estructurado 2-3 veces por semana.
- Terapia de reminiscencia y orientación a la realidad.
- Ejercicio físico aeróbico regular (caminatas de 30 min/día).
- Dieta MIND o mediterránea.
- Control estricto de factores de riesgo vascular.
- Higiene del sueño y tratamiento de apnea del sueño si aplica.
- Actividades de socialización estructurada — prevenir aislamiento.